

2.2.4 มีการนำระบบ PHR บรรจุในแผน BCP กรณีระบบสารสนเทศหลักล้ม



บทนำ

ปัจจุบันโรงพยาบาลขอนแก่นได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช้โปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล HOSxP ใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ แยกหน่วยงานเป็น ระบบ มีหน่วยงานเวชระเบียนทำการบันทึกเก็บข้อมูลผู้รับบริการ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป กลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวช ให้บริการผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบกับการจัดทำโปรแกรม มาใช้เพื่อความสะดวก ในการ ปฏิบัติงาน และสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งข้อมูล สารสนเทศ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึง จำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บ และการดูแล รักษาข้อมูล สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล จึงจำเป็นต้องมีแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) เพื่อ ใช้ในกรณีที่สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากจากการถูกโจมตีจากระบบ Server ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ระบบล่มจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือ จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลสามารถนำไปใช้เพื่อตอบสนอง และ ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยไม่ให้สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวส่งผล กระทบให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล ต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้ อย่างต่อเนื่อง การที่กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล ไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อ การให้บริการผู้มารับบริการ กับหน่วยงานภายในโรงพยาบาล การจัดทำแผนบริหารความต่อ เนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือ กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญสามารถกลับมา ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือตามระดับการให้บริการ ที่กำหนดไว้ซึ่ง จะช่วยให้สามารถ ลดระดับความรุนแรง ของ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานอื่นๆได้

วัตถุประสงค์ของแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
๕. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต

สมมติฐานในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้มีการ จัดเตรียมไว้
๒. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสำรองระบบสารสนเทศ โดยระบบสารสนเทศสำรองนั้น มีได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
๓. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และ เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาล

ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้ รองรับสถานการณ์การเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณ พื้นที่โรงพยาบาลฯ ฆานาได้แก่ เหตุการณ์อัคคีภัย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๑. ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ

เหตุการณ์สภาวะ	อาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติงาน หลัก	วัสดุ อุปกรณ์ที่ สำคัญ	เทคโนโลยี สารสนเทศ และ ข้อมูลที่สำคัญ	บุคลากร	ผู้ให้บริการ
เหตุการณ์อัคคีภัย	✓	✓	✓	✓	✓
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์			✓		✓

๒. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงาน สามารถบริหารจัดการ การดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญ จึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้องระบุไว้ใน แผนความ ต่อเนื่องซึ่ง การเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้

- ๒.๑ ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นทำให้สถานที่ ปฏิบัติงานหลัก ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผล ให้บุคลากร ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราว หรือระยะยาว

๒.๒ ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้

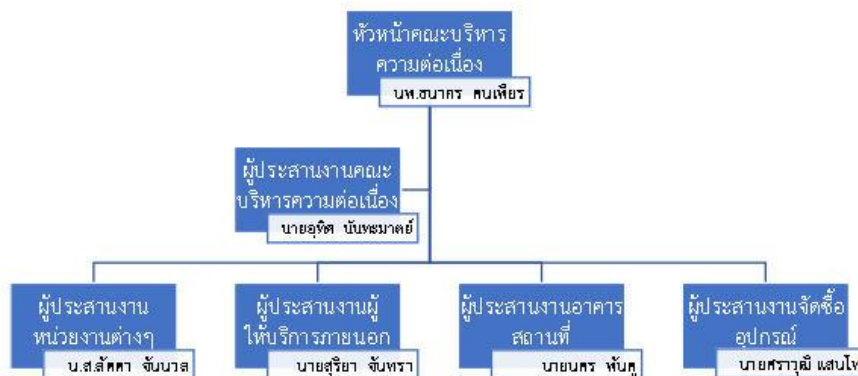
๒.๓ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบงาน เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูล ที่สำคัญ ไม่สามารถ นำมา ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ

๒.๔ ผลกระทบด้านบุคลากร หลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากร หลัก ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ

๒.๕ ผลกระทบด้านการให้บริการที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ให้บริการ ไม่สามารถติดต่อหรือให้ บริการหรือส่งมอบงานได้

การบริหารความต่อเนื่องของโรงพยาบาล

โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของโรงพยาบาลฯตามขึ้น โดยมี โครงสร้างดังนี้



จากโครงสร้าง แต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์

ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อเจ้าหน้าที่ และบทบาท ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่กำหนดให้ เป็นเจ้าหน้าที่หลัก

ตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์ติดต่อ
หัวหน้าคณะกรรมการความต่อเนื่อง	นพ.ชนากกร คนเพียร	๐๙๑ ๘๕๘ ๙๘๓๗
ผู้ประสานงานคณะกรรมการความต่อเนื่อง	นายอุทิศ นันทะมาตย์	๐๘๕ ๔๑๑ ๗๙๗๒
ผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ	น.ส.ลลิตา จันทวล	๐๘๙ ๒๘๖ ๙๑๙๑
ผู้ประสานงานผู้ให้บริการภายนอก	นายสุริยา จันทรา	๐๙๗ ๓๓๔ ๘๘๖๑
ผู้ประสานงานอาคารสถานที่	นายนคร พันธุ์	๐๙๕ ๘๙๘ ๕๓๙๖
ผู้ประสานงานการจัดซื้ออุปกรณ์	นายศราวุฒิ แสนไท	๐๘๖ ๘๕๘ ๓๘๒๘

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity strategy)

๑. ด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

กรณีสถานที่ปฏิบัติงานหลักของกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล ดิจิทัลผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น ๒ ได้รับความเสียหาย โรงพยาบาลกำหนดพื้นที่สำรองที่ให้องค์กรกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดิจิทัลผู้ป่วยนอกเดิม

๒. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

๒.๑ กำหนดให้จัดเก็บสำรองในปริมาณที่เหมาะสม ตามรอบการสั่งซื้อผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ ประสานหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างให้จัดซื้ออุปกรณ์สำรองที่กำหนดให้มีการจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ สำรองพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน โรงพยาบาลได้

๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

๓.๑ กำหนดให้มีระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสำรองข้อมูลที่สำคัญของโรงพยาบาล และสามารถโอนย้าย ระบบข้อมูลสารสนเทศ ไปดำเนินการ ได้ที่ พื้นที่ ปฏิบัติงานสำรองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

๓.๒ กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล สามารถใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์สำรองของโรงพยาบาล เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญของโรงพยาบาล สามารถดำเนินการ ต่อไปได้ในช่วง สภาวะวิกฤต

๓.๓ ดำเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ Manual ไปก่อน แล้วจึงบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบ การบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศเมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ

๓.๔ กำหนดให้ทำการสร้าง Server Replication สำรองไว้

๔. ด้านบุคลากรหลัก

กำหนดให้ใช้บุคลากรสำรองทดแทน ภายในกลุ่มงานเดียวกัน

๕.ด้านผู้ให้บริการ

๕.๑ จัดให้มีผู้ให้บริการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มากกว่า ๑ ราย เพื่อลดผลกระทบในกรณี ที่มีผู้ให้บริการแห่งหนึ่งไม่สามารถให้บริการได้โดยประสานกับผู้ให้บริการเพื่อแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำการแก้ไขและจัดส่งอุปกรณ์ ทดแทนในยามฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ในด้านระบบเครือข่าย สามารถใช้อุปกรณ์สำรอง ที่มีอยู่ของโรงพยาบาลแทนได้ก่อนชั่วคราว

๕.๒ โรงพยาบาล ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบในการจ่าย ๖ กระไฟฟ้า เพื่อให้โรงพยาบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีไฟฟ้าดับ

๕.๓ กำหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านตัวปล่อยสัญญาณ Wi Fi แบบพกพา (Pocket Wi Fi) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริการข้อมูลที่สำคัญ ที่ต้องใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตกับส่วนกลาง

การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรในกรณีที่เกิดการหยุดชะงัก (Business Impact Analysis)

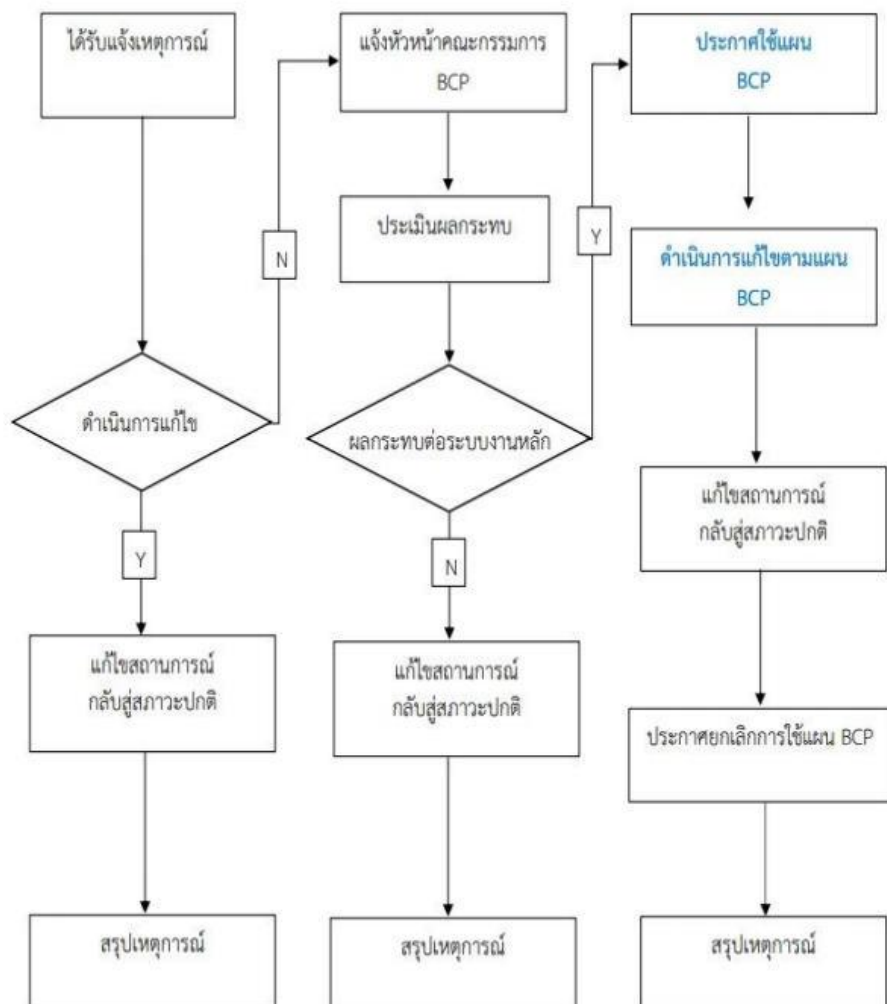
เป็นการวิเคราะห์ช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักเมื่อเกิด สภาวะวิกฤต ภัยคุกคาม เริ่มส่งผล กระทบกับการ ดำเนินงานของหน่วยงาน จะมีการแจ้งสถานการณ์ทุก ๑๕ นาที ให้กับหน่วยงาน ที่ได้รับ ผลกระทบ เมื่อเหตุการณ์ถึงระดับ รุนแรงจะดำเนินการประกาศใช้แผน BCP กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดย สามารถพิจารณา ดังนี้

ระบบงาน	ระยะเวลาการหยุดทำงาน		
	ระยะเวลาน้อยกว่า ๓๐ นาที	ระยะเวลา ๓๐-๖๐ นาที	ระยะเวลามากกว่า ๖๐ นาที
ระบบ HOSxP	ปานกลาง	รุนแรง	รุนแรง
ระบบเครือข่ายทั้งระบบ	ปานกลาง	รุนแรง	รุนแรง
ระบบอินเทอร์เน็ต	ไม่รุนแรง	ไม่รุนแรง	ปานกลาง

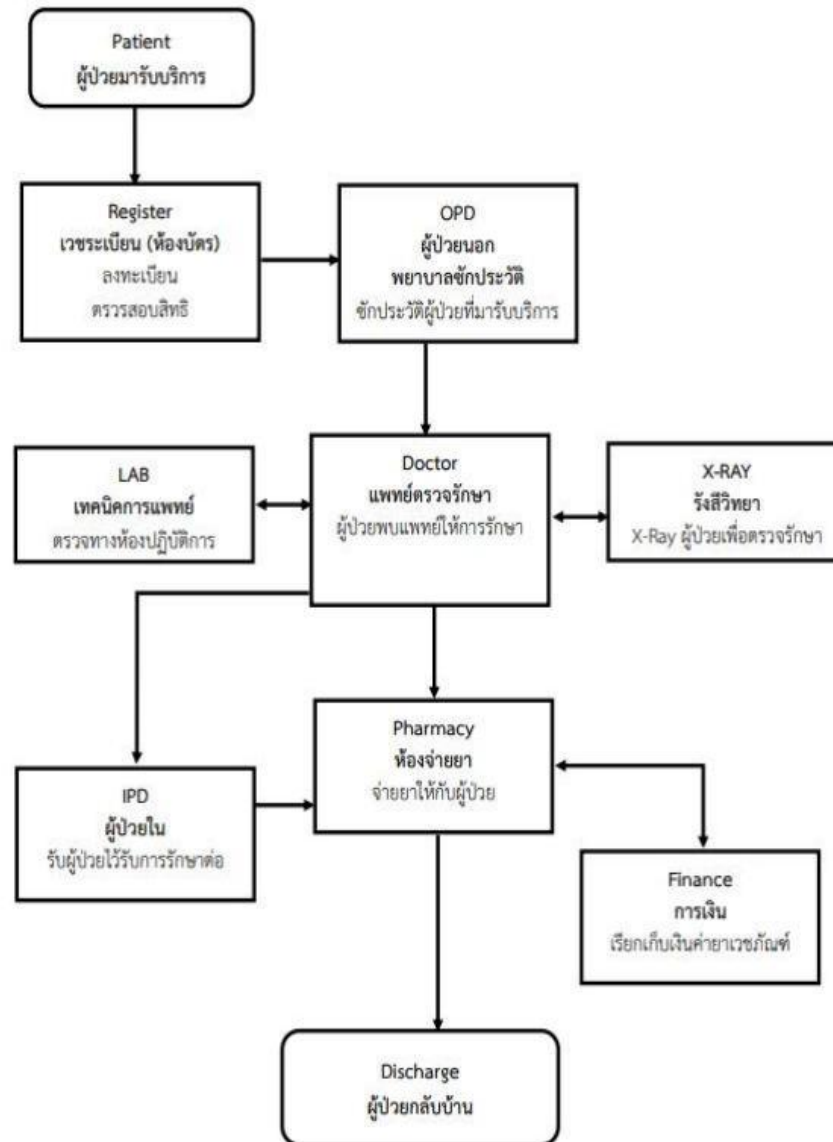
รายละเอียดของระดับเหตุการณ์ต่างๆ

ระดับของเหตุการณ์	รายละเอียด
ไม่รุนแรง	ระดับเหตุการณ์ ที่ไม่รุนแรง เป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ หน่วยงาน ต่างๆ ยังสามารถรอได้
ปานกลาง	ระดับปานกลางเป็นระดับเหตุการณ์ที่ คณะกรรมการ BCP จะต้องมีการ ประชุมเพื่อประเมินระดับ ความรุนแรงของสถานการณ์
รุนแรง	ระดับเหตุการณ์ถึงระดับที่รุนแรงเป็นระดับที่วิกฤตจะดำเนินการประกาศ ใช้แผน BCP ในการดำเนินงานทันที

ลำดับขั้นตอนในการประกาศใช้แผนสร้างความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน



ภาพรวมของการดำเนินแผนสร้างความต่อเนื่อง



วิธีการดำเนินงานเมื่อประกาศใช้แผน Business Continuity Plan (BCP)

กระบวนการ ทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้

กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่องและเพื่อความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทางโรงพยาบาลชานุมาน ได้จัดทำ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานต่าง ดังนี้

หน่วยงานเวชระเบียน (ห้องบัตร)

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานเวชระเบียน ในขณะที่ระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้

ขั้นตอนการให้บริการหน่วยงาน เวชระเบียน

๑. ผู้ป่วยรับใบนำส่งผู้ป่วย (บัตรคิว) ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์
๒. ผู้ป่วยรับการคัดกรองเบื้องต้นที่จุดคัดกรอง
๓. รับหลักฐานในการมารับบริการจากผู้ป่วย ผู้ป่วยจะต้องนำหลักฐานยืนยันตัวบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้มา แสดงทุกครั้งที่มาใช้บริการ
 - ๓.๑ บัตรประจำตัวประชาชน
 - ๓.๒ บัตรโรงพยาบาล
 - ๓.๓ สูติบัตร
 - ๓.๔ เอกสารอื่น ๆ ที่มีรูป ที่ทางราชการออกให้และสามารถยืนยันตัวบุคคลได้
๔. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบผู้ป่วยว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่หรือผู้ป่วยรายเก่า จากคอมพิวเตอร์ในตึก

สำรองข้อมูลแบบ Offline (Notebook Slave Server)

- ๔.๑ ผู้ป่วยรายใหม่

ค้นประวัติเดิมจากคอมพิวเตอร์ในตึก หรือ สืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP Viwer ผ่านทางเว็บไซต์ URL <https://phr@moph.go.th/phr/> หากไม่พบข้อมูล ให้ลงข้อมูลใหม่

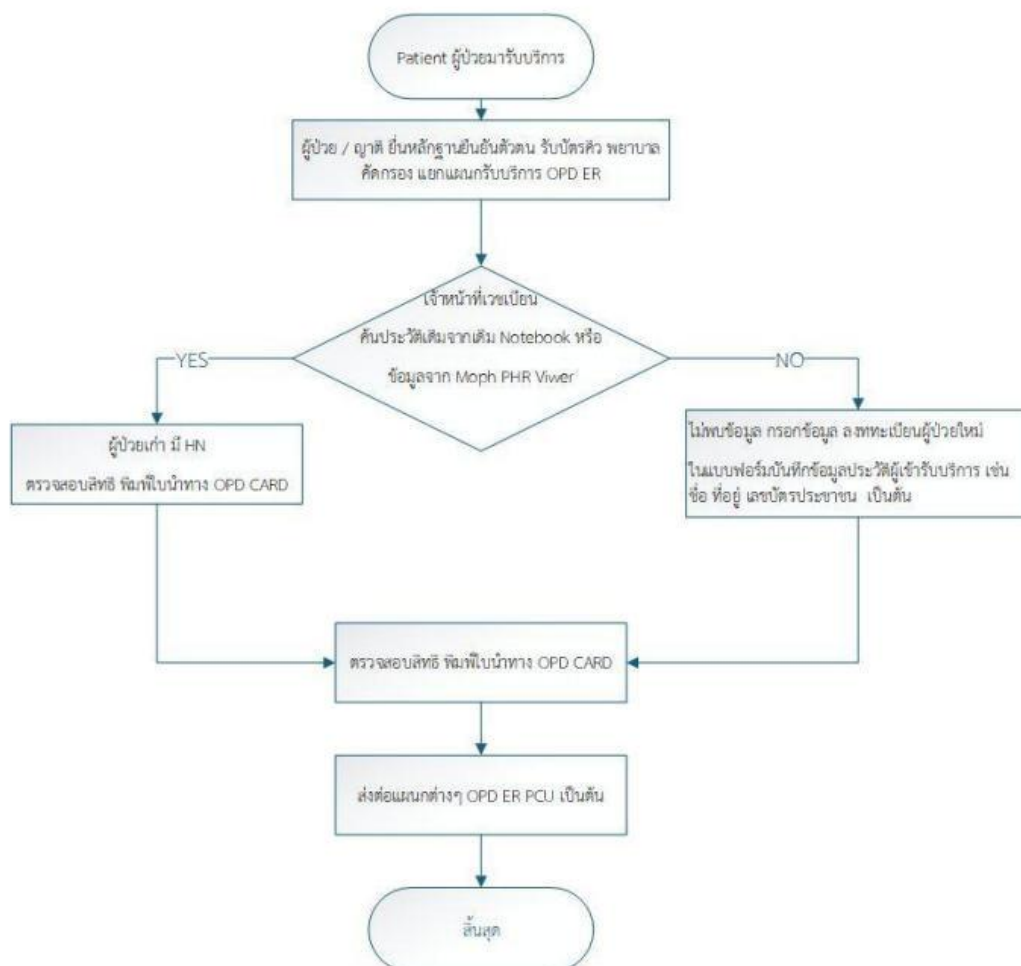
กรอกข้อมูลผู้ป่วยลงในแบบบันทึกผู้ป่วยรายใหม่

ทำการเขียน ชื่อ สกุล อายุ ลงในใบนำส่งผู้ป่วย

- ๔.๒ ผู้ป่วยรายเก่า

ค้นประวัติเดิมจากคอมพิวเตอร์ในตึกหรือ สืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP Viwer ผ่านทางเว็บไซต์ URL <https://phr@moph.go.th/phr/> พบข้อมูลพิมพ์ประวัติ OPD CARD จากคอมพิวเตอร์ในตึก
ส่งใบนำส่งผู้ป่วย ส่งต่อไปยังแผนกต่างๆ OPD ER พยาบาลซักประวัติ
ส่งพบแพทย์ทำการตรวจรักษาต่อไป

แผนการดำเนินงานหน่วยงานเวชระเบียน เมื่อระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้



ขั้นตอนการให้บริการหน่วยงานเวชระเบียน สำหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล Admit

๑. รับเอกสารหลักฐานในการตรวจรักษาจากแพทย์ตรวจรักษา ในกรณีผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
๒. จัดทำเอกสาร Admit ถ้าเนาเอกสารเก็บไว้ รอสถานการณกลับมาเป็นปกติ ทำ Admit ในระบบ
๓. ส่งเอกสาร Admit ฉบับจริงคืนให้แผนกที่ให้บริการ OPD ER นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยใน

แผนการดำเนินงานหน่วยงานเวชระเบียน เมื่อระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้ Admit

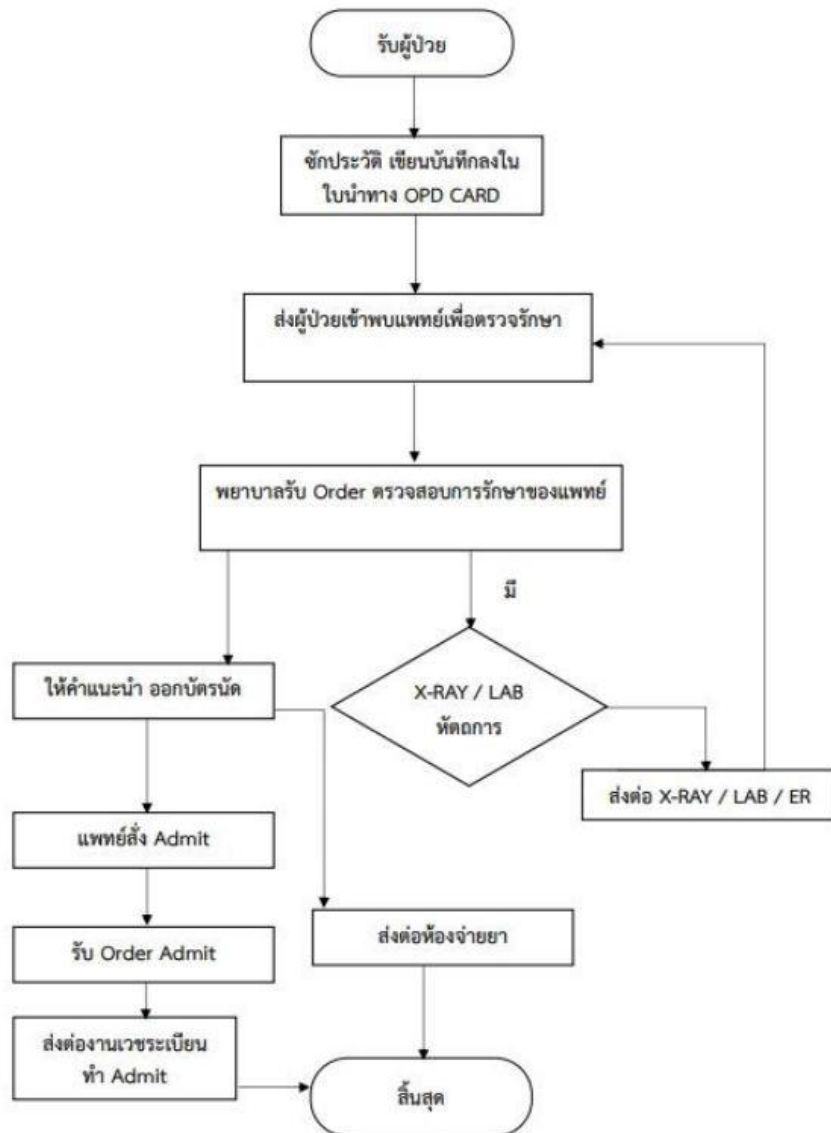


❖ **หน่วยงาน ผู้ป่วยนอก OPD**

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ผู้ป่วยนอก ในขณะที่ระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้

๑. รับเอกสารผู้ป่วยจากหน่วยงาน เวชระเบียน
๒. พยาบาลซักประวัติผู้ป่วย เขียนบันทึกลงในใบนำทาง
๓. ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา
๔. พยาบาลจัดรับ Order แพทย์ตรวจสอบเอกสารที่แพทย์ทำการรักษา
 - ๔.๑ แพทย์สั่งตรวจ X Ray สั่งตรวจ LAB หรือส่งจำหัตถการ ให้ดำเนินการดังนี้
 - ส่งต่อผู้ป่วยไปหน่วยงาน X Ray หรือ ห้องปฏิบัติการ LAB
 - ส่งจำหัตถการที่แผนก ER
 - ผู้ป่วยตรวจเสร็จ ส่งผู้ป่วยพบแพทย์ตรวจรักษาอีกครั้ง
 - ๔.๒ แพทย์ตรวจเสร็จแล้วให้รับยากลับบ้าน หรือมีนัดมาติดตามการรักษา
 - ส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาที่ห้องจ่ายยา
 - ทำการเขียนใบนัดให้มารับบริการในครั้งต่อไป
 - ๔.๓ แพทย์ตรวจแล้วส่งนอนโรงพยาบาลรับการรักษาต่อ
 - ให้ญาติไปยื่นเอกสารรับยาที่ห้องจ่ายยา
 - เจ้าหน้าที่นำเอกสาร ไปยื่นที่ห้องเวชระเบียนเพื่อลงทะเบียน Admit
๕. หากต้องการสืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP viewer ผ่านทางเว็บไซต์ URL <https://phr๑.moph.go.th/phr/>

แผนการดำเนินงานหน่วยงานผู้ป่วยนอก OPD เมื่อระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้



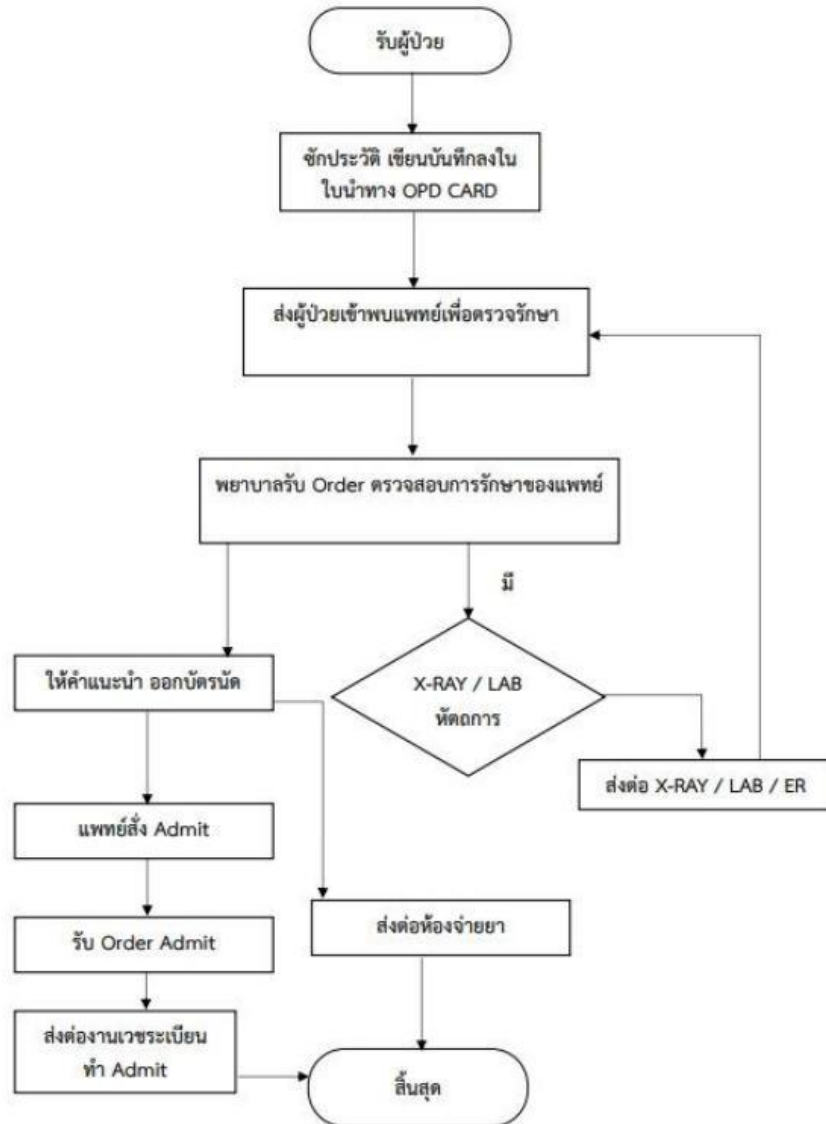
❖ **หน่วยงาน อุบัติเหตุและนิติเวช ER**

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อุบัติเหตุและนิติเวช ในขณะที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้

๑. รับเอกสารผู้ป่วยจากหน่วยงาน เวชระเบียน
๒. พยาบาลซักประวัติผู้ป่วย เขียนบันทึกลงในใบนำทาง
๓. ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา
๔. พยาบาลจัดรับ Order แพทย์ตรวจสอบเอกสารที่แพทย์ทำการรักษา
 - ๔.๑ แพทย์สั่งตรวจ X Ray สั่งตรวจ LAB ให้ดำเนินการดังนี้
 - ส่งต่อผู้ป่วยไปหน่วยงาน X Ray หรือ ห้องปฏิบัติการ LAB
 - ผู้ป่วยตรวจเสร็จ ส่งผู้ป่วยพบแพทย์ตรวจรักษาอีกครั้ง
 - ๔.๒ แพทย์ตรวจเสร็จแล้วให้รับยากลับบ้าน หรือมีนัดมาติดตามการรักษา
 - ส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาที่ห้องจ่ายยา
 - ทำการเขียนใบนัดให้มารับบริการในครั้งต่อไป
 - ๔.๓ แพทย์ตรวจแล้วส่งนอนโรงพยาบาลรับการรักษาต่อ
 - ให้ญาติไปยื่นเอกสารรับยาที่ห้องจ่ายยา
 - แนะนำญาติหลังรับยาเสร็จให้นำเอกสาร ไปยื่นที่ห้องเวชระเบียนเพื่อลงทะเบียน Admit
๕. หากต้องการสืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP viewer ผ่านทางเว็บไซต์ URL

<https://phre.moph.go.th/phir/>

แผนการดำเนินงานหน่วยงาน อุบัติเหตุและนิติเวช ER เมื่อระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้



❖ หน่วยงาน องค์กรแพทย์ Doctor

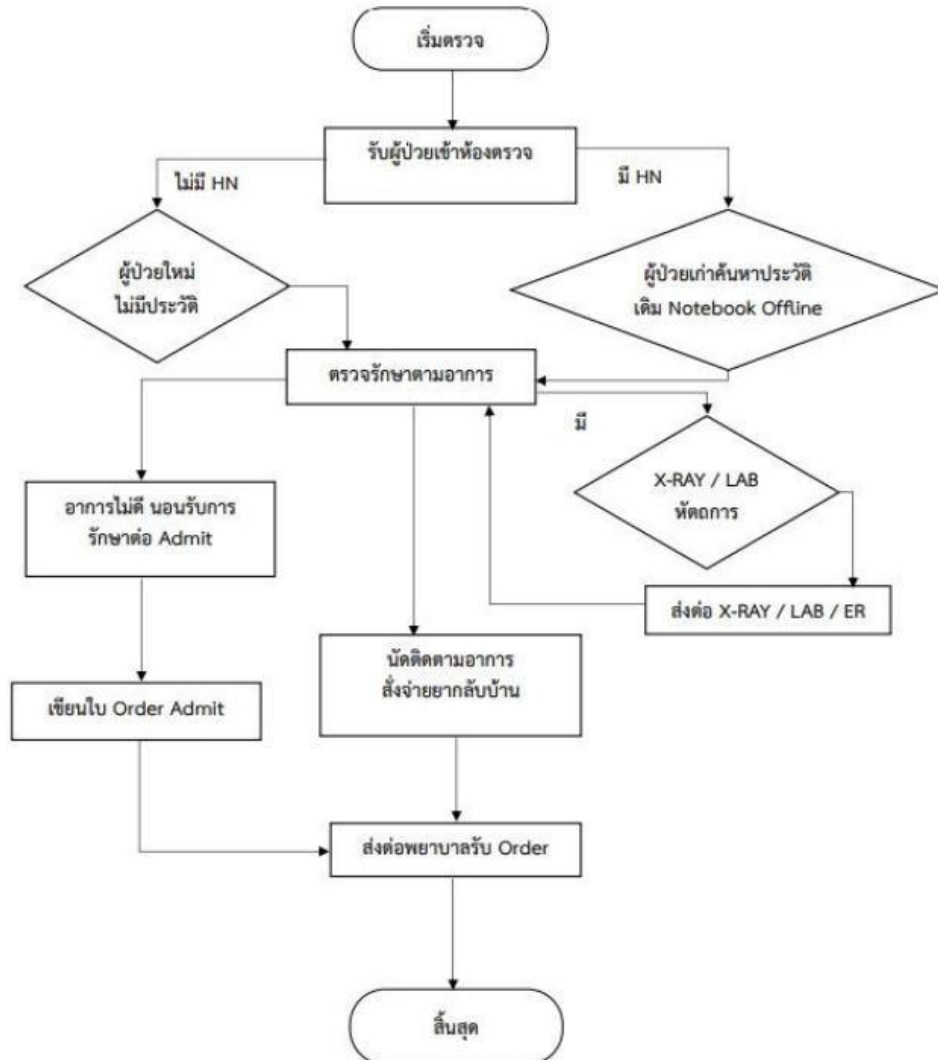
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน องค์กรแพทย์ในขณะที่ระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้

๑. รับเอกสารใบซักประวัติผู้ป่วยจากพยาบาลซักประวัติ
๒. ให้คำปรึกษาผู้ป่วย ตรวจสอบรักษาตามอาการ ผู้ป่วยเก่า ค้นหาประวัติการรักษาเดิมจาก Notebook Offline
เขียนใบสั่งยาในกระดาษ และประวัติการรักษาใน OPD CARD ที่พยาบาลซักประวัติส่งมา
ส่งตรวจ LAB X Ray
นัดติดตามการรักษา ส่งรับยากลับบ้าน
ตรวจแล้วทำการรักษาต่อในโรงพยาบาล Admit
๓. ผู้ป่วยใหม่ ไม่สามารถค้นหาประวัติการรักษาเดิมจาก Notebook Offline ได้
เขียนใบสั่งยาในกระดาษ และประวัติการรักษาใน OPD CARD ที่พยาบาลซักประวัติส่งมา
ส่งตรวจ LAB X Ray
นัดติดตามการรักษา ส่งรับยากลับบ้าน
ตรวจแล้วทำการรักษาต่อในโรงพยาบาล Admit

๔. หากต้องการสืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP viewer ผ่านทางเว็บไซต์ URL

<https://phr๑.moph.go.th/phr/>

แผนการดำเนินงานหน่วยงานองค์กรแพทย์ Doctor เมื่อระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้



❖ **หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ (LAB)**

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ในขณะที่ระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้

๑. รับใบนำส่งตรวจ LAB ของผู้ป่วย
๒. ทำการตรวจ LAB ตาม Order แพทย์แบบ Manual
๓. รายงานผล LAB ส่งให้หน่วยงานที่ส่งตรวจ
๔. ส่งต่อผู้ป่วยไปหน่วยงานที่ส่งตรวจ LAB เพื่อพบแพทย์ทำการรักษาต่อไป
๕. หากต้องการสืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP viewer ผ่านทางเว็บไซต์ URL

<https://phr๑.moph.go.th/phr/>

แผนการดำเนินงานหน่วยงานผู้ป่วยนอก OPD เมื่อระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้

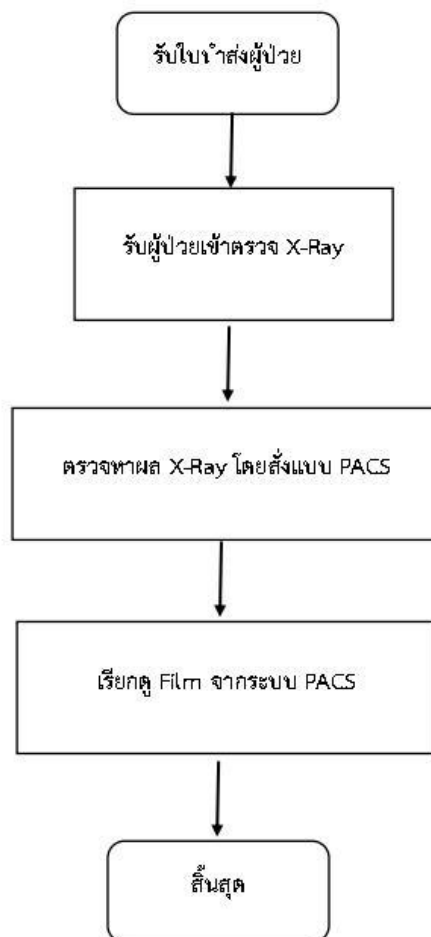


❖ หน่วยงาน รังสีวิทยา X-RAY

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน รังสีวิทยา ในขณะที่ระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้

๑. รับเอกสารผู้ป่วยจากหน่วยงานอื่นส่งมา X Ray
๒. รับผู้ป่วยเข้าห้องทำการ X Ray ผู้ป่วย
๓. ส่งฟิล์มเข้าระบบ PACS
๔. สามารถเรียกดูข้อมูลฟิล์ม X Ray ได้จากระบบ PACS
๕. หากต้องการสืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP viewer ผ่านทางเว็บไซต์ URL <https://phr๑.moph.go.th/phr/>

แผนการดำเนินงานหน่วยงานรังสีวิทยา X-RAY เมื่อระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้



❖ หน่วยงานเภสัชกรรม Pharmacy

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เภสัชกรรม ในขณะที่ระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้

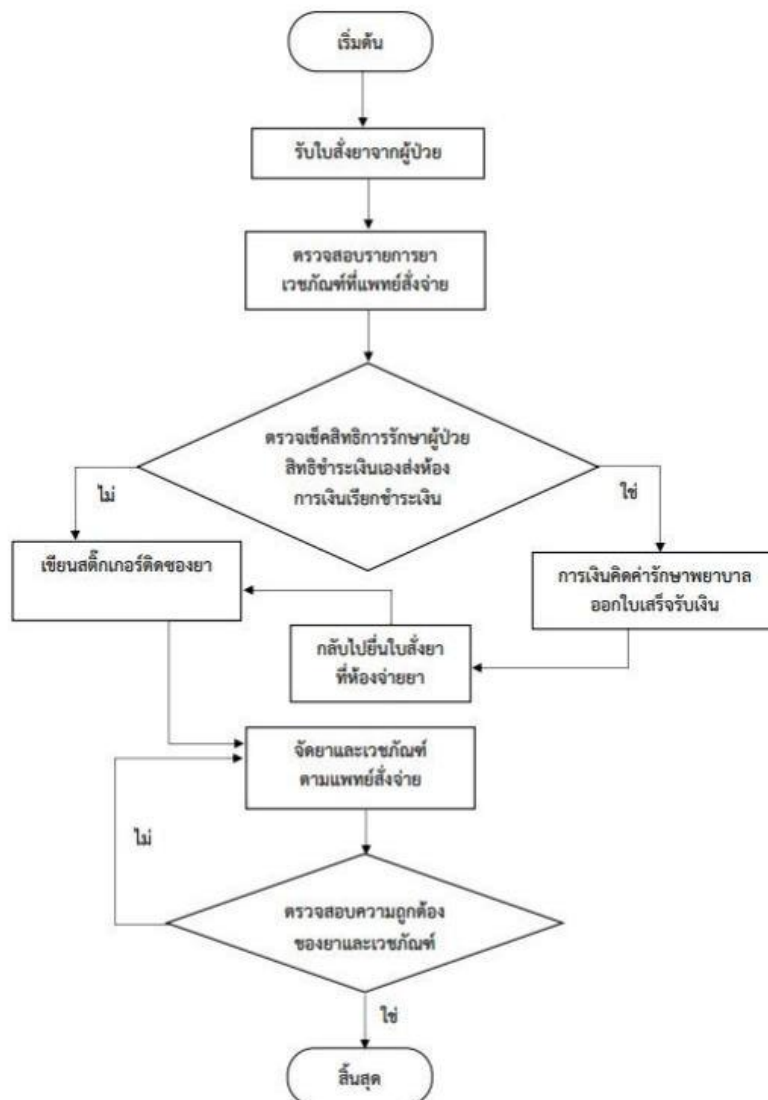
๑. รับเอกสารใบสั่งยาจากจุดพยาบาลรับ Order แพทย์ตรงเสร็จกลับบ้าน หรือ Admit
๒. ตรวจเช็คใบสั่งยา ชื่อ สกุลผู้ป่วย ใช้สิทธิการรักษาอะไร ผู้ป่วยต้องชำระเงินหรือไม่ มีชำระเงินส่งต่อ

หน่วยงานการเงิน เพื่อให้ผู้ป่วยไปชำระเงินก่อนมารับยา

๓. ตรวจสอบรายการส่งจ่ายยาจากแพทย์เขียนชื่อยา จำนวน วิธีใช้วันที่ ในสติ๊กเกอร์ติดซองยา
๔. ตรวจสอบข้อมูลการแพ้ยา จากคอมพิวเตอร์โน้ตบุค Notebook Offline
๕. เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของการบรรจุซองยา และเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนจ่ายยา
๖. หากต้องการสืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP viewer ผ่านทางเว็บไซต์ URL

<https://phr0.moph.go.th/phr/>

แผนการดำเนินงานหน่วยงานเภสัชกรรม Pharmacy เมื่อระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้



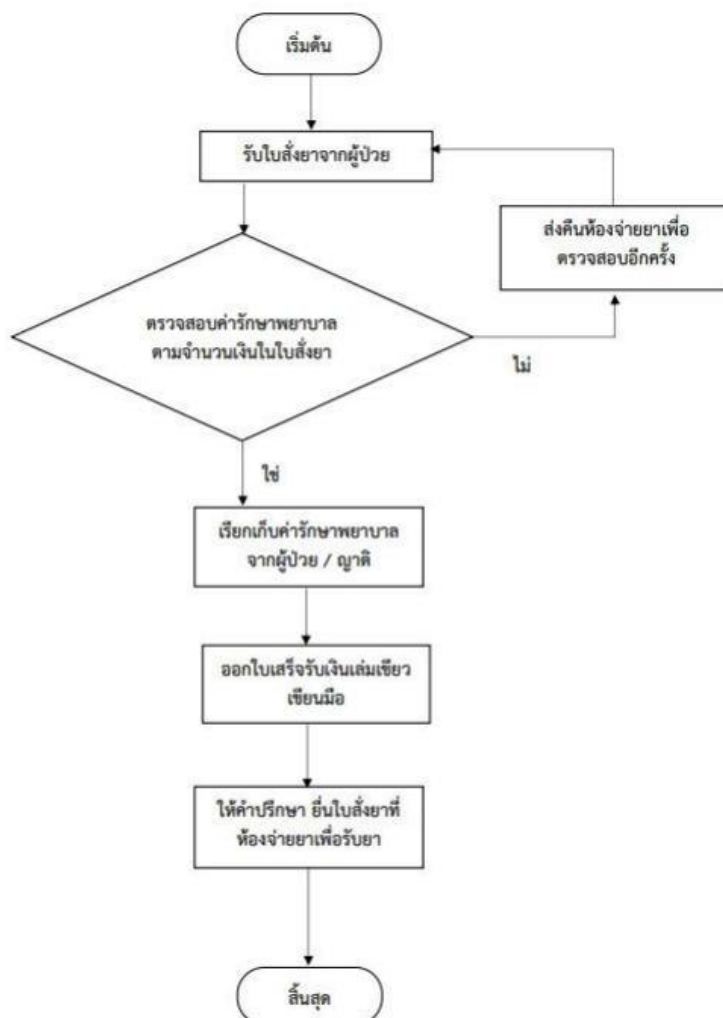
❖ **หน่วยงาน งานการเงิน Finance**

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน งานการเงิน ในขณะที่ระบบ HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้

๑. รับเอกสารใบสั่งยาค่าใช้จ่าย จากผู้มารับบริการ ที่ห้องจ่ายยาส่งมาชำระเงิน
๒. ตรวจสอบเช็คสิทธิการรักษาชำระเงินเองในใบสั่งยา ชื่อ สกุลผู้ป่วย ให้ถูกต้อง
๓. เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย หรือญาติที่มาชำระเงิน ตามราคาค่ารักษาพยาบาล
๔. ทำการออกใบเสร็จรับเงินเล่มเขียว โดยเขียนด้วยลายมือตัวเอง
๕. แนะนำผู้ป่วยหรือญาตินำใบสั่งยา พร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นรับยาที่ห้องจ่ายยา
๖. หากต้องการสืบค้นข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านระบบ MOPH PHP viewer ผ่านทางเว็บไซต์ URL

<https://phr๑.moph.go.th/phr/>

แผนการดำเนินงานหน่วยงานห้องจ่ายยา Pharmacy เมื่อระบบ HOSXP ไม่สามารถใช้งานได้



วิธีการดำเนินงานเมื่อยกเลิกการใช้แผน Business Continuity Plan (BCP)



❖ **หน่วยงาน เวชระเบียน (ห้องบัตร)**

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เวชระเบียน เมื่อระบบ HOSXP กลับมาใช้งานได้

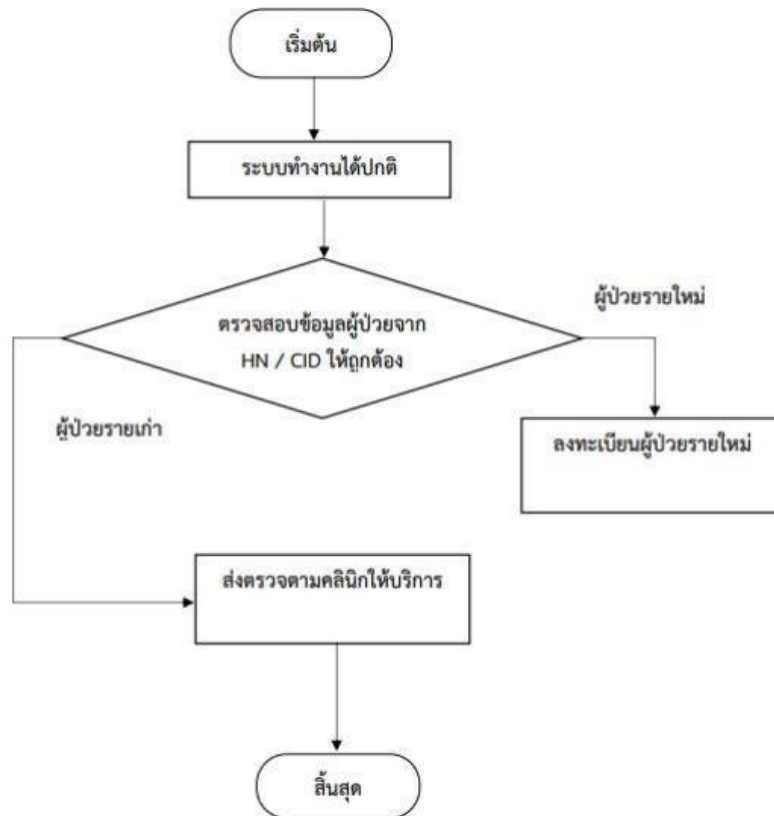
ขั้นตอนการให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

๑. ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจากเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลข HN ของผู้ป่วยที่ทำการบันทึกไว้ตอนระบบล่ม

๑.๑. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ลงทะเบียนผู้ป่วยลงในระบบ HOSXP ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบบันทึกผู้ป่วยรายใหม่ ทำการส่งตรวจตามคลินิกที่ให้บริการ ให้ตรงตามข้อมูลตอนระบบ HOSXP ล่ม

๑.๒ กรณีผู้ป่วยรายเก่าทำการส่งตรวจตามคลินิกที่ให้บริการ

แผนการดำเนินงานหน่วยงาน เวชระเบียน เมื่อระบบ HOSXP กลับมาใช้งานได้ปกติ



ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เวชระเบียน สำหรับผู้ป่วย Admit เมื่อระบบ HOSxP

ใช้งานได้ปกติ

๑. นำเอกสารรำนําข้อมูล Charge Admit มาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเ้ามาลงในระบบ
๒. ลงทะเบียนผู้ป่วยใน Admit ให้กับผู้ป่วยที่แพทย์สั่งนอนโรงพยาบาล

แผนการดำเนินงานหน่วยงาน เวชระเบียน เมื่อระบบ HOSxP กลับมาใช้งานได้ปกติ

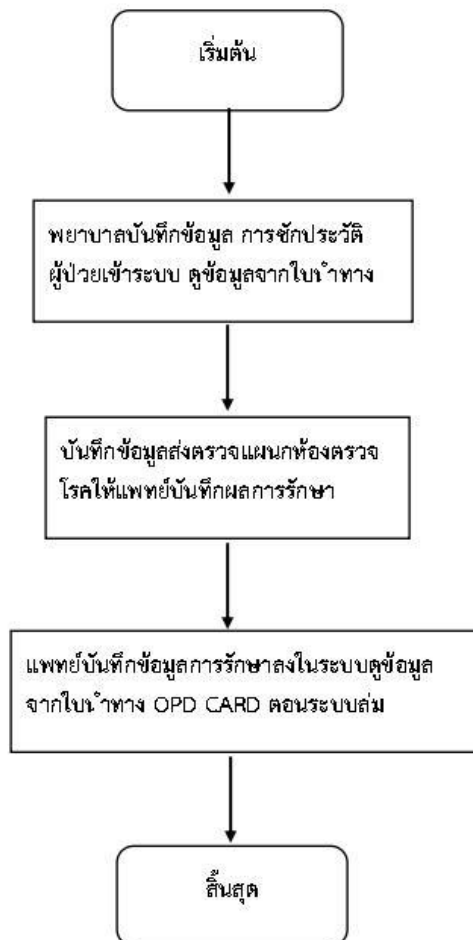


 หน่วยงาน ผู้ป่วยนอก OPD

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ผู้ป่วยนอก ในขณะที่ระบบ HOSxP กลับมาใช้งานได้ปกติ

๑. พยาบาลทำการบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP
๒. บันทึกข้อมูลการซักประวัติผู้ป่วย ดูข้อมูลจากบันทึกในใบนำทาง OPD CARD ตอนระบบล่ม
๓. ส่งบันทึกข้อมูลที่ซักประวัติเข้าห้องตรวจ เพื่อให้แพทย์ทำการบันทึกในระบบ

แผนการดำเนินงานหน่วยงานผู้ป่วยนอก OPD เมื่อระบบ HOSxP ใช้งานได้ปกติ



ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน รังสีวิทยา ในขณะที่ระบบ HOSxP กลับมาใช้งานได้ปกติ

๑. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มาใช้บริการตอนระบบล่ม ในระบบ HOSxP
๒. นำข้อมูลผู้ป่วยในระบบ HOSxP และในระบบ PACS มาเชื่อมเข้าหากัน
๓. รายงานผล X Ray จากระบบ FACS นำเข้าระบบ HOSxP

แผนการดำเนินงานหน่วยงาน รังสีวิทยา X-RAY เมื่อระบบ HOSxP ใช้งานได้ปกติ



ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ในขณะที่ระบบ HOSxP กลับมาใช้งานได้ปกติ

๑. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ในระบบ HOSxP
๒. รายงานผล LAB ในระบบ LIS เหมือนปกติ ส่งผลตรวจเข้าระบบ HOSxP รายงานผลการตรวจแจ้งหน้า งานเข้าสู่ผลในระบบ

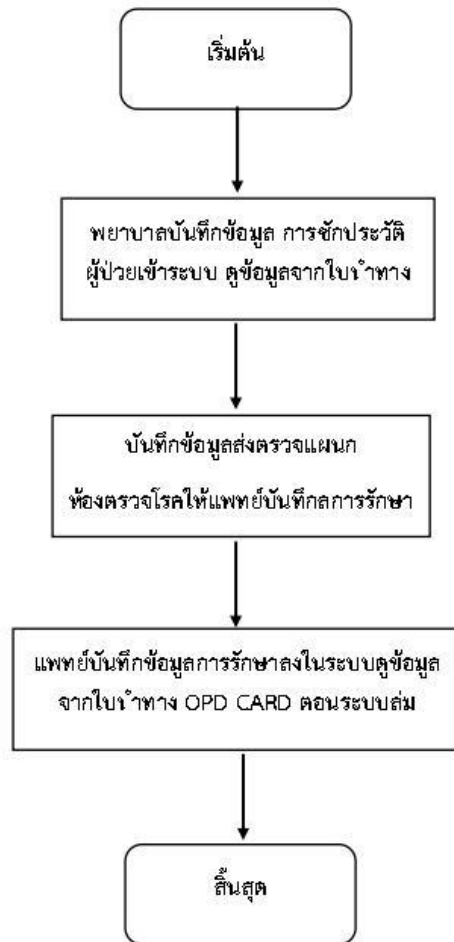
แผนการดำเนินงานหน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ LAB เมื่อระบบ HOSxP ใช้งานได้ปกติ



ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อุบัติเหตุและนิติเวช ในขณะที่ระบบ HOSxP กลับมาใช้งานได้ปกติ

๑. พยาบาลทำการบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP
๒. บันทึกข้อมูลการซักประวัติผู้ป่วย ดูข้อมูลจากบันทึกในใบนำทาง OPD CARD ตอนระบบล่ม
๓. ส่งบันทึกข้อมูลที่ซักประวัติเข้าห้องตรวจ เพื่อให้แพทย์ทำการบันทึกในระบบ

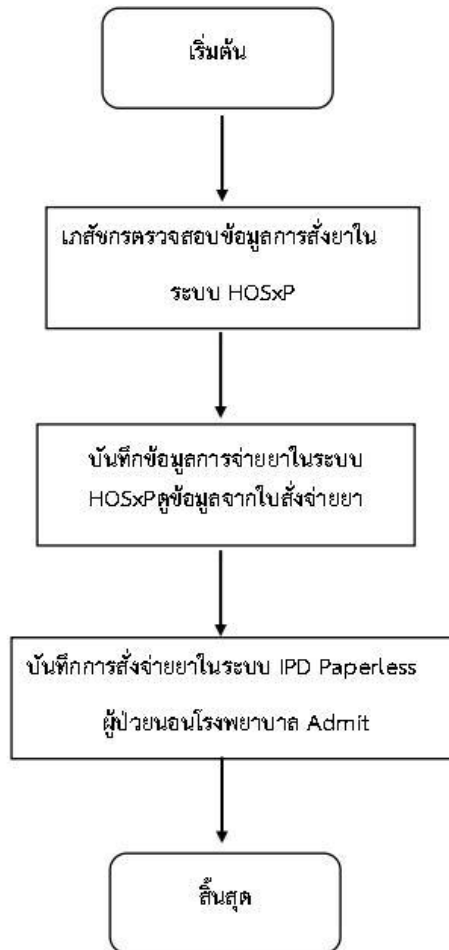
แผนการดำเนินงานหน่วยงานผู้ป่วยนอก OPD เมื่อระบบ HOSxP ใช้งานได้ปกติ



ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เกสซ์กรรม ในขณะที่ระบบ HOSxP กลับมาใช้งานได้ปกติ

๑. เกสซ์กรทำการตรวจสอบข้อมูลสั่งยาในระบบ HOSxP
๒. เกสซ์กรทำการบันทึกข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วย จากการส่งต่อจากห้องตรวจโรค เข้าระบบ
๓. ตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งจ่ายยาในโปรแกรม HOS Merge IPD Paperless ผู้ป่วย Admit

แผนการดำเนินงานหน่วยงานผู้ป่วยนอก OPD เมื่อระบบ HOSxP ใช้งานได้ปกติ

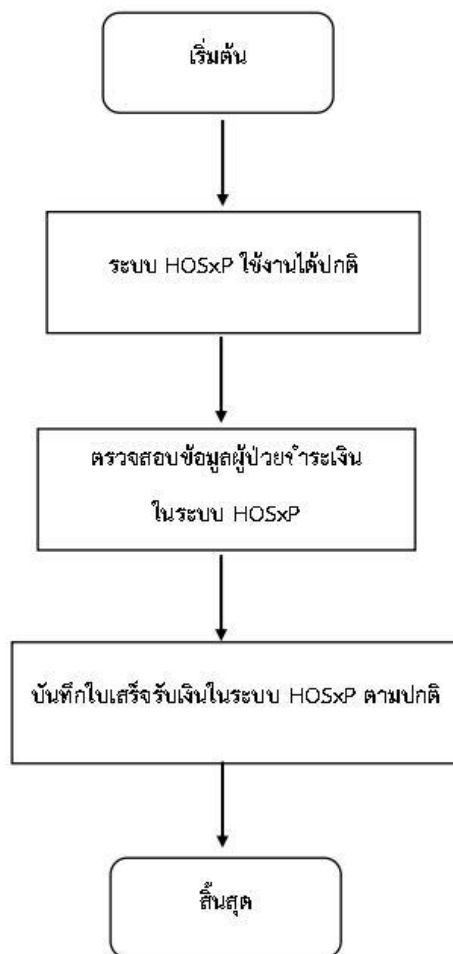


ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน งานการเงิน ในขณะที่ระบบ HOSxP กลับมาใช้งานได้ปกติ

๑. ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่ชำระเงิน ในระบบ HOSxP

๒. บันทึกข้อมูล ออกใบเสร็จรับเงินในระบบตามปกติ

แผนการดำเนินงานหน่วยงานการเงิน Finance เมื่อระบบ HOSxP ใช้งานได้ปกติ



ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน องค์การแพทย์ในขณะที่ระบบ HOSxP กลับมาใช้งานได้ปกติ

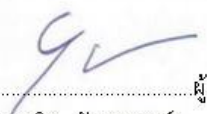
๑. แพทย์บันทึกข้อมูลการรักษาเข้าในระบบ HOSxP
๒. ผู้ป่วยนอนรักษาต่อที่โรงพยาบาล Admit
แพทย์บันทึกข้อมูล Admit ในระบบโปรแกรม HOSxP IPD Paperless
แผนการดำเนินงานหน่วยงาน แพทย์ Doctor เมื่อระบบ HOSxP ใช้งานได้ปกติ

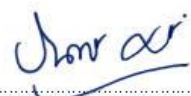


ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ

ในการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ ขอให้บุคลากรของหน่วยงาน คำนึงถึงความปลอดภัย ในชีวิตของตนเองและ
ผู้ช่วยเป็นสำคัญ

ขั้นตอนและกิจกรรม	บทบาทความรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑. แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติให้กับหัวหน้าคณะกรรมการความ ต่อเนื่อง และแจ้งเหตุการณ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับ ผลกระทบ	คณะกรรมการความต่อเนื่อง	☐
๒. จัดประชุมคณะกรรมการความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ เสียหายผลกระทบต่อการดำเนินงาน การให้บริการและ ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง	คณะกรรมการความต่อเนื่อง	☐
๓. ทบทวนกระบวนการที่เร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่าง สูง (หากไม่ดำเนินการ) ดังนั้น จำเป็นต้องดำเนินงานหรือ ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)	คณะกรรมการความต่อเนื่อง	☐
๔. รายงานหัวหน้าคณะกรรมการความต่อเนื่องทราบโดย ครอบคลุมประเด็นดังนี้ - ความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและการ ให้บริการ - ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง - กระบวนการที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ดำเนินการ และจำเป็นต้องดำเนินงานหรือ ปฏิบัติงานด้วยมือ	คณะกรรมการความต่อเนื่อง	☐
๕. ประเมินศักยภาพและความสามารถของกลุ่มงาน สุขภาพจิตที่ดี ในการดำเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤติ พร้อมระบุทรัพยากรที่ จำเป็นต้องใช้ในการบริหาร ความต่อเนื่องตามแผนการ จัดหาทรัพยากร	หัวหน้าคณะกรรมการความ ต่อเนื่อง	☐
๖. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความ ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร	ผู้ประสานงานในด้านต่างๆ	☐
๗. แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ แก่ หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อรับทราบและ ดำเนินการ เช่น แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน สำรอง	ผู้ประสานงานคณะกรรมการความ ต่อเนื่อง	☐
๘. รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ	หัวหน้าคณะกรรมการความ ต่อเนื่อง	☐


 (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นายอุทิศ นันทมัตย์)
 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ


 (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายสนากร คนเพียร)
 นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น